

Chapitre 1

Panorama de la protection sociale

F. Candau (UPPA-TREE)

Six risques et un principe de solidarité

- Les politiques sociales prennent en charge une **baisse de revenus** ou une **hausse de dépenses** liées à des risques socio-économiques, sanitaires, ou à des événements du cycle de vie (chômage, maladie, vieillesse).
- Les comptes de la protection sociale en distinguent six catégories :
 - *santé* (maladie, invalidité, accidents du travail) ;
 - *vieillesse-survie* (retraites, minimum vieillesse, dépendance, réversion) ;
 - *maternité-famille* ;
 - *emploi* (indemnisation du chômage, préretraites, insertion) ;
 - *logement* ;
 - *pauvreté et exclusion sociale* (dont le RSA).
- La prise en charge repose sur un principe de **solidarité**, intragénérationnelle (les actifs en emploi financent les prestations chômage) ou intergénérationnelle (des actifs vers les retraités).

Périmètre, définition, plan

- **Périmètre de ce cours** : plus large que la Sécurité sociale, qui n'en couvre qu'une partie. S'y ajoutent l'assurance chômage, les aides de l'État et des collectivités, les mutuelles.
- Plus étroit que l'État providence, dont sont exclues ici la législation du travail, la fiscalité et l'éducation.
- Ce périmètre est celui des **assurances sociales**, celles dont la loi rend l'affiliation obligatoire et dont le financement ne dépend pas du risque propre de chacun. L'assurance privée est facultative et tarifée selon le risque.
- **Plan** : les trois types de systèmes d'assurance et les deux logiques de couverture, puis le système français, ses branches et ses dépenses, enfin la dynamique démographique.

Trois types de systèmes d'assurance

Il existe trois types de systèmes d'assurance.

- Un système **public et obligatoire** (France, assurance maladie de base).
- Un système **privé mais obligatoire**, la loi imposant de s'assurer auprès de compagnies en concurrence (Suisse, Pays-Bas).
- Un système **privé et facultatif**, que l'État soutient en exonérant d'impôt et de cotisations les contrats souscrits (États-Unis, couverture maladie des salariés).

Aucun pays ne relève d'un seul type. En France, l'assurance maladie de base est publique et obligatoire, la complémentaire santé des salariés est privée et obligatoire depuis 2013, et l'État la soutient en exonérant de cotisations sociales la part payée par l'employeur.

Le modèle contributif (Bismarck)

- Deux “systèmes” sont traditionnellement comparés.
- Dans un système contributif, aussi dit Bismarkien, la protection sociale est une assurance liée au travail, qui couvre ceux qui exercent une activité et cotisent, ainsi que leur famille. Le droit à la prestation naît de la cotisation.
- Son objet est de remplacer un revenu d’activité perdu => la prestation est proportionnelle au salaire antérieur. On fait perdurer les inégalités salariales.
- La prestation est un “salaire différé”, et non un transfert de la collectivité.
- La gestion revient à des caisses distinctes de l’État, où siègent employeurs et salariés (assurances sociales allemandes des années 1880, lois françaises de 1898-1930, Sécurité sociale de 1945).

Le modèle universel (Beveridge)

- Le modèle universel, dit beveridgien, fait de la protection sociale un droit attaché à la personne, indépendamment de son activité, et le droit à la prestation naît de l'appartenance à la collectivité.
- Son objet est de garantir à chacun un socle de ressources et l'accès aux soins, si bien que la prestation est **forfaitaire**, la même pour tous quel qu'ait été le revenu antérieur.
- Financement par l'impôt.
- La gestion revient à l'État (rapport Beveridge de 1942, pays nordiques).

Quatre dimensions pour situer un système

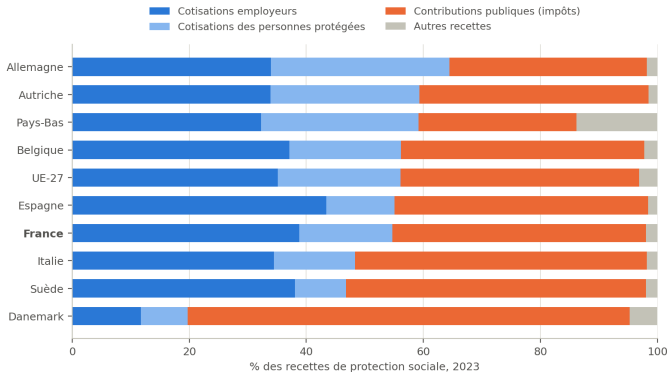
	Contributif (Bismarck)	Universel (Beveridge)
Accès aux droits	Emploi et cotisation	Résidence, citoyenneté
Prestations	Proportionnelles au salaire	Forfaitaires
Financement	Cotisations sur les salaires	Impôt
Gestion	Caisses, partenaires sociaux	Administration de l'État
Redistribution	Horizontale, entre risques	Verticale, entre revenus

- La frontière entre le contributif et le solidaire est **en partie conventionnelle**.

Les trois mondes de l'État-providence

- Les retraites et l'assurance chômage sont restées contributives, la santé, la famille et la pauvreté sont devenues universelles.
- Esping-Andersen (1990) classe les systèmes selon le degré d'indépendance à l'égard du marché qu'ils procurent, la **démarchandisation**, et distingue trois régimes, **libéral**, **social-démocrate** et **conservateur-corporatiste**.

La part des cotisations en Europe



Cotisations : 20 % des recettes au Danemark, 64 % en Allemagne, 55 % en France. Source : Eurostat, ESSPROS.

La France, branche par branche

- La France est partie du modèle contributif en 1945.
- Sa position dans la grille **n'est pas la même selon la branche**, il faut donc les prendre une à une.
- **Régime général** : les salariés du privé, 40-45 % des prestations.
- **Les branches** : maladie, vieillesse, famille, accidents du travail, autonomie depuis 2020, chacune gérée par une caisse nationale tenue d'assurer son équilibre financier.
- **Hors Sécurité sociale** : le chômage et l'insertion.

Le financement s'est déplacé

- **Cotisations** : assises sur les salaires, elles ouvrent des droits. C'est le financement d'origine.
- **Fiscalisation** : depuis les années 1980-1990, recours croissant à l'impôt (CSG en 1991, CRDS en 1996, impôts et taxes affectés aux branches).
- Part des cotisations dans les recettes : **80 % en 1990, 55 % en 2023.**
- Partie d'un financement aussi contributif que celui de l'Allemagne, la France est désormais à la moyenne européenne.
- Effets sur le coût du travail et l'emploi : chapitre 8.

Les branches selon la grille

Branche	Ouverture des droits	Règle principale	Financement
Maladie	Résidence depuis 2016	Tarif de convention, ticket modérateur	cotis. employeurs 38 %, CSG 23 %, impôts 29 %
Retraites	Cotisation, carrière	64 ans, 43 annuités, 25 meilleures années	cotis. employeurs 32 %, salariés 22 %, impôts 10 %, CSG 7 %
Chômage	6 mois sur 24	≈ 57 % du brut, 18 mois au plus avant 55 ans	contributions employeurs 60 %, CSG 38 %
Famille	Résidence, enfants	Dès le 2 ^e enfant, modulées depuis 2015	cotis. employeurs 63 %, CSG 24 %, impôts 10 %
Accidents du travail	Emploi salarié	Réparation forfaitaire, cotisation selon sinistralité	cotis. employeurs 92 %
Minima sociaux	Résidence, ressources	Prestation différentielle	impôt
Autonomie	Résidence, perte d'autonomie	Plan d'aide, participation selon revenu	CSG 89 %, impôts 11 %

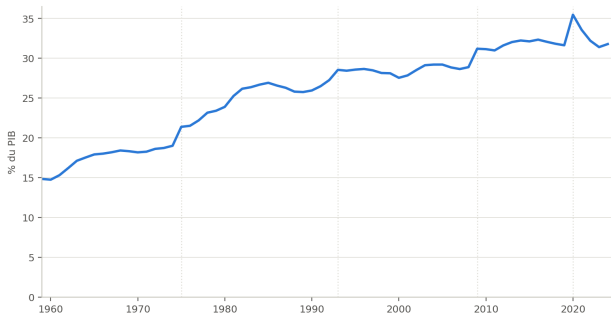
Un système hybride

La France a commencé contributive et s'est universalisée sans jamais changer de modèle d'ensemble.

- **Dualisation** (Palier, 2005) : une sphère d'assurance contributive pour les risques du travail, une sphère universelle et fiscalisée pour la maladie, la famille et la pauvreté.
- **Hybridation** (Elbaum, 2011) : la France ne relève ni d'un modèle ni de l'autre, branche par branche.
- Le financement, proportionnel aux salaires au début des années 1990, est devenu progressif sous l'effet de la CSG et des allègements sur les bas salaires (Zemmour, 2015).
- L'hybridation n'est pas propre à la France, mais elle y est marquée : point de départ plus contributif, point d'arrivée plus fiscalisé.

Un tiers du PIB

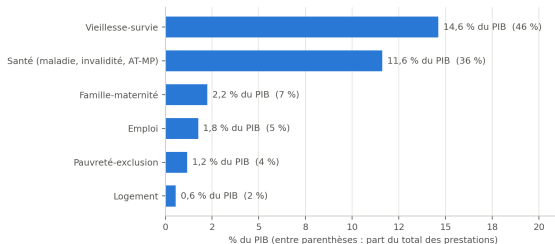
- La part des prestations dans le PIB a plus que doublé, de **14,8 % en 1959** à **31,8 % en 2024**.



Traits verticaux : années de contraction du PIB (1975, 1993, 2009, 2020). Sources : DREES, comptes de la protection sociale ; INSEE.

Par habitant et par risque

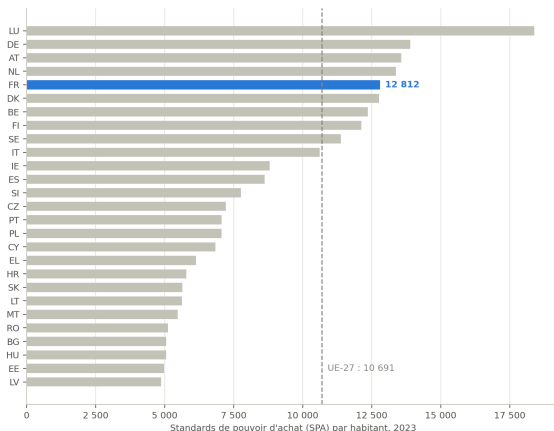
- En 2024, environ **13 600 euros par habitant**, dont 6 220 euros pour la seule vieillesse-survie.
- Santé : innovations médicales, prix des interventions et des médicaments, dépenses de fin de vie.



Source : Eurostat, ESSPROS.

Une exception française ?

- La France est 5^e sur 27 par habitant, mais la première de l'Union en % du PIB.

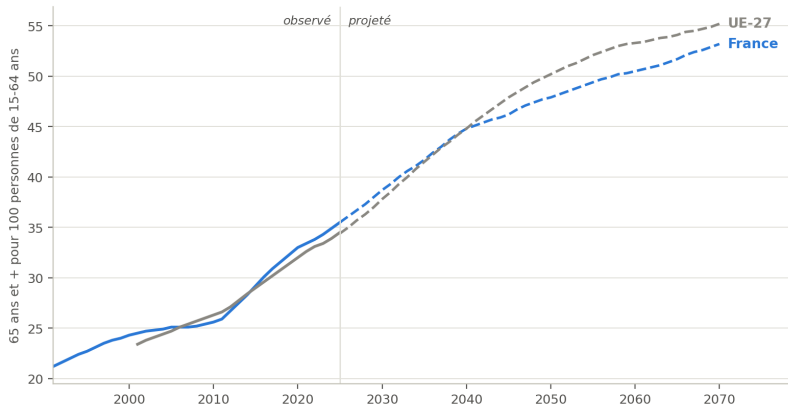


Le ratio de dépendance des personnes âgées

$$\text{ratio de dépendance des personnes âgées} = \frac{\text{personnes de 65 ans et plus}}{\text{personnes de 15 à 64 ans}} \times 100$$

- Il mesure approximativement le nombre de personnes que chaque centaine d'actifs potentiels doit financer.
- Ce ratio a fortement augmenté (figure suivante).
- La France comptait environ cinq personnes d'âge actif par personne âgée en 1990, et elle en comptera moins de deux en 2070.

Ratio de dépendance des 65 ans et plus



Observé puis projeté (scénario central). Source : Eurostat.

Lire les projections

- Le vieillissement est général en Europe. La France y échappe un peu en fin de période, grâce à une fécondité longtemps plus élevée.
- **À 15 ans** : l'incertitude vient presque uniquement du solde migratoire.
- **À l'horizon 2070** : la fécondité devient l'hypothèse la plus sensible, devant les migrations et l'espérance de vie.
- **L'ordre de grandeur reste robuste** : les personnes qui auront 65 ans en 2050 sont déjà nées.
- Ce fait structure tout le cours, des retraites (chapitre 3) à la santé et la dépendance (chapitre 4), jusqu'au financement (chapitre 8).

Conclusion

- **Aucun modèle pur** : née contributive, la protection sociale française a ouvert l'accès aux droits par la résidence dans plusieurs branches et fiscalisé une partie de son financement.
- **Un tiers du PIB**, dominé par la vieillesse et la santé.
- Le vieillissement continuera d'en tirer les dépenses, la question du financement avec elles.
- Les chapitres suivants reprennent ces fils : l'histoire de cette construction, puis chaque branche avec ses tensions propres.

Les ordres de grandeur à retenir

- Prestations de protection sociale : environ **un tiers du PIB** (31,8 % en 2024), contre 14,8 % en 1959, soit environ **13 600 euros par habitant**.
- **Vieillesse-survie (46 %) et santé (36 %)** concentrent plus de 80 % des prestations.
- La France est **au sommet de l'UE en % du PIB**, mais 5^e par habitant.
- Part des cotisations dans les recettes : de **80 % en 1990 à 55 % aujourd'hui**.
- Ratio de dépendance des 65 ans et plus : d'environ **36 aujourd'hui à 53 en 2070**.